SYNDROME DU HARNAIS

FICHE TECHNIQUE

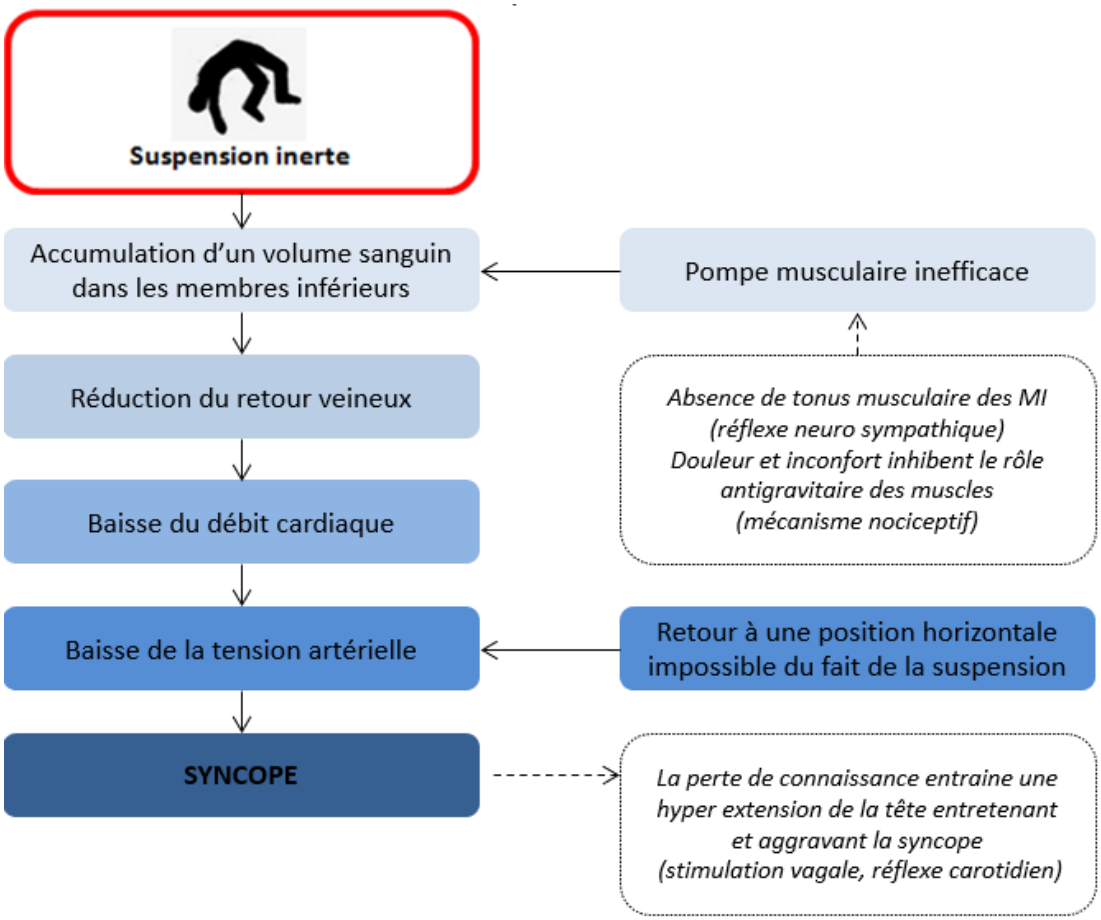
MAI 2015

DEFINITION

Le syndrome du harnais (SDH) se définit comme la survenue rapide d'un état de choc, engageant à très court terme le pronostic vital, consécutif à une suspension prolongée inerte dans un harnais.

Celle-ci peut survenir à la suite d'un malaise, d'une défaillance technique, d'épuisement ou d'un traumatisme.
On parle également de syndrome de suspension ou de traumatisme de suspension.

MECANISME



⇨ Perturbation de l'équilibre du système cardio-vasculaire conduisant à une défaillance du système circulatoire avec une ischémie cérébrale entrainant rapidement la mort.

SIGNES DU SDH

- ✓ Sensation de malaise générale, douleurs membres inférieurs (MI)
- ✓ Sueurs, nausées
- ✓ Vertiges, bouffées de chaleur
- ✓ Sensation d'oppression thoracique
- ✓ Augmentation de la fréquence cardiaque et apparition de troubles du rythme
- ✓ Augmentation de la tension artérielle
- ✓ Perte de connaissance

Rédaction : © Docteur Frédéric Bussienne / Alexandre Gomez de Miranda ©ROPE&WEB

SYNDROME DU HARNAIS

FICHE TECHNIQUE

MAI 2015

SDH PRIMAIRE ET SDH SECONDAIRE

- Le SDH est la cause du malaise: on parle de SDH primaire. La victime se retrouve en suspension inerte à la suite d'épuisement, de défaillance technique

- Le SDH survient à la suite d'une perte de connaissance: on parle de SDH secondaire (malaise, épilepsie, traumatisme …)

SDH, UNE URGENCE ABSOLUE

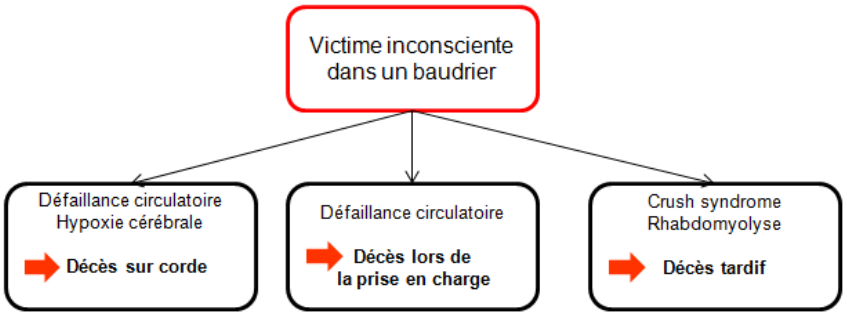
On distingue deux aspects de l'urgence absolue induite par le syndrome du harnais:

- **Immédiat:**

La suspension inerte sur corde peut entrainer le décès en quelques minutes.
Nécessité d'un décrochage rapide, effectuer un **dégagement d'urgence**.

- **A court terme:**

Accumulation de toxines dans les membres due à une suspension passive, risque de **rhabdomyolyse**, d'**hyperkaliémie** pouvant entrainer le décès dans les heures suivant le décrochage de la victime.
Nécessité d'une **médicalisation** et d'une **prise en charge hospitalière** (centre hospitalier capable de dialyse).



CONDUITES A TENIR

Victime consciente

Retarder le SDH : parler à la victime
Lui demander de mobiliser ses membres inférieurs (pédale, sangle…)
Redescendre la victime au sol
Si évacuation rapide impossible, installer un dispositif de retenue de buste

Détresse circulatoire à rechercher, allonger la victime
Prise d'information: **durée de suspension, présence de signes du SDH**

Suspension supérieure à 30 min avec signes : transport sur un centre hospitalier capable de dialyse.

Victime inconsciente

Effectuer un **dégagement d'urgence**
Redresser la victime si évacuation immédiate impossible
Allonger la victime au sol, **prise en charge médicale indispensable**
Toute victime d'un SDH est considérée comme **polytraumatisée** jusqu'à preuve du contraire (SDH secondaire)
Recherche de complications métaboliques associées (**hyperkaliémie**)

Transport sur un centre hospitalier capable de dialyse.

Rédaction : © Docteur Frédéric Bussienne / Alexandre Gomez de Miranda ©ROPE&WEB

ALGORITHME DE PRISE EN CHARGE

